SDD 254 Sujet n°1

Spécialité : Onco-hématologie

Date : 24/10/2024
Auteur : Hélène RUBIN
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Education/prévention
Item(s) en lien avec la station	294 – Traitement des cancers, principales molécules 295 – Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la maladie
Situation(s) de départ en lien avec la station	254 – Prescrire des soins associés à l'initiation d'une chimiothérapie
Matériel nécessaire à la station	Table, chaises pour étudiant, PS et examinateur
Contexte de la station	**Patiente de 53 ans, récemment diagnostiquée d'un lymphome B diffus à grandes cellules, vient pour l'initiation d'une chimiothérapie par R-CHOP en HDJ hématologie.**

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de 2e semestre en stage libre en Hématologie, et vous voyez en consultation Mme I. Claudine, 53 ans, pour lymphome B diffus à grandes cellules. Vous avez réalisé la consultation d'annonce la semaine dernière et la patiente avait été très marquée par le diagnostic.

Vous souhaitez débuter un protocole de chimiothérapie par R-CHOP (Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine, Prednisone), qui aura lieu en HDJ d'hématologie par voie intraveineuse tous les 21 jours.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour:

- Informer la patiente des effets indésirables attendus les plus fréquents.
- Prescrire les soins et traitements associés à l'initiation de la chimiothérapie.

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen clinique
- Faire d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Informe la patiente du risque d'infections graves lié à une baisse du nombre globules blancs dans le sang (neutropénie fébrile)	1 pt
2.	Informe sur le risque de saignements d'origine vésicale (cystite hémorragique)	1pt
3.	Informe sur le risque de problèmes cardiaques (cardiomyopathie dilaté et/ou troubles du rythme)	1pt
4.	Informe sur le risque de constipation	
5.	Informe sur le risque de nausées et/ou de vomissements ET de constipation	1 pt
6.	Informe sur la possibilité de sentir des fourmis dans les orteils ou les doigts (neuropathie périphérique)	1pt
7.	Informe sur le risque de perte de cheveux	1pt
8.	Explique qu'il va prescrire des bains de bouches	1 pt
9.	Vérifie les vaccinations ET prescrit une vaccination contre le pneumocoque 13 valences + Covid + Grippe	1pt
10.	Explique qu'il va prescrire des antiémétiques	1pt
11.	Explique qu'il va prescrire un médicament pour protéger la vessie (Uromitexan)	1 pt
12.	Informe la patiente sur la possibilité de rencontrer la psychologue du service	1pt

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

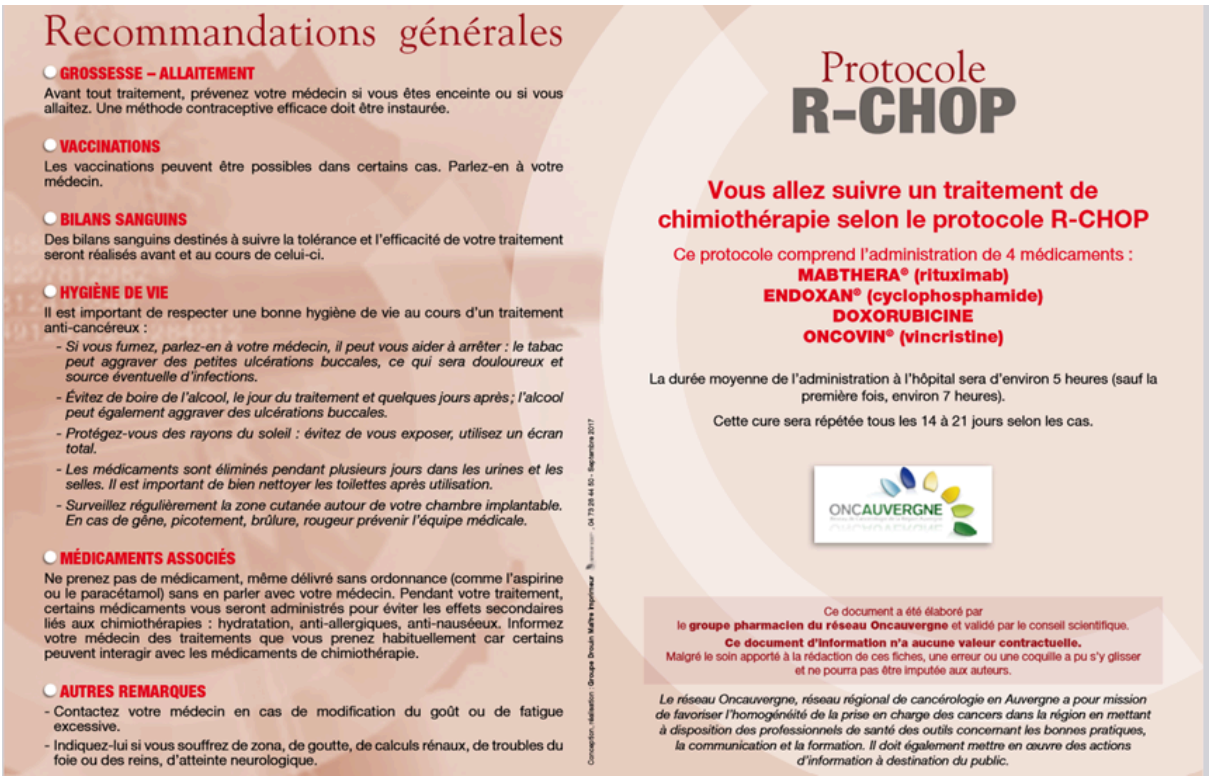
11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL sur 16 points	X points

NB :

Dans l'évaluation de la communication et de l'attitude, il sera attendu de l'étudiant que celui-ci s'informe sur le moral ou sur la compréhension de la patiente après la consultation d'annonce de la semaine dernière ("Avez-vous bien compris ce qu'on s'est dit la semaine dernière ?" ; "Comment vous-sentez vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu ?").



Recommandations générales

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.*
- *Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.*
- *Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.*
- *Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.*
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur prévenir l'équipe médicale.*

MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin. Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole
R-CHOP

Vous allez suivre un traitement de chimiothérapie selon le protocole R-CHOP

Ce protocole comprend l'administration de 4 médicaments :
MABTHERA® (rituximab)
ENDOXAN® (cyclophosphamide)
DOXORUBICINE
ONCOVIN® (vincristine)

La durée moyenne de l'administration à l'hôpital sera d'environ 5 heures (sauf la première fois, environ 7 heures).

Cette cure sera répétée tous les 14 à 21 jours selon les cas.

ONCAUVERGNE

Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
Fréquents		
• Réactions allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, sensation de malaise, rougeurs, migraines.	• Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection de Mabthera.	• Consulter immédiatement l'équipe médicale.
• Nausées et vomissements.	• Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement, et fractionner les repas.	• Si les vomissements ont lieu moins de une heure après la prise des comprimés (sauf lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin.
• Alopécie (chute des cheveux) réversible.	• Pas de soin agressif type teinture ou permanente.	• Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.
• Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres.	• Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	• Faire systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction de produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie).
• Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang.	• Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	• Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
• Constipation.	• Alimentation riche en fibres, boire beaucoup d'eau. Pratiquer quelques exercices légers.	• Le signaler au médecin.
• Coloration des urines en rouge.		• Ne pas vous inquiéter, c'est un phénomène normal lié à l'élimination du produit coloré.
Moins fréquents		
• Pulsations cardiaques accélérées ou irrégulières, essoufflement, gonflement des pieds.		• Prévenir le médecin, des examens cardiaques peuvent être nécessaires.
• Difficultés respiratoires.		• Prévenir rapidement le médecin.
• Engourdissement ou fourmillement dans les doigts et les orteils, troubles de la vue ou de l'ouïe, difficulté à marcher.		• Le signaler au médecin.
• Perturbation du fonctionnement rénal.	• Boire régulièrement.	• Surveiller son poids et sa diurèse (quantité d'urine par 24h) et prévenir le médecin en cas de prise de poids ou de faible quantité d'urines émises par 24 heures.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ OU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Consignes génériques pour le patient ou PSS :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Contexte de la station :

Vous êtes Mme Claudine I et vous avez 53 ans. On vous a diagnostiqué un cancer du sang : un lymphome B diffus à grandes cellules, et vous avez déjà vu l'interne la semaine dernière pour la consultation d'annonce, et celà vous avait beaucoup marqué.
Aujourd'hui vous revoyez cet interne pour discuter des traitements.

Plan de la station ECOS :

PS et étudiant assis face à face.

Phrase de démarrage du patient simulé ou du PSS :

Bonjour Docteur, alors aujourd'hui on va discuter des médicaments c'est ça ?

Identité du patient :

Femme de 53 ans.
Taille : 170 cm ; Poids : 72 kg ; IMC : 25 kg/m²

Mode de vie :

Mariée, habite avec son conjoint dans une maison dans le 94.
1 fils de 28 ans et une fille de 25 ans, n'habitent plus dans la maison.
Maison propre, pas d'animaux à domicile.

Travaille comme conseillère de vente.
Pas de voyage récent hors de France, pas de voyage prévu dans l'année.
Loisirs : aquarelliste, bâteau à voile pendant les vacances.

Pas de consommation d'alcool.
Pas d'usage de tabac (jamais fumeuse). Pas d'autre toxique.

Comportement global :

La patiente très stressée par le diagnostic de lymphome, a besoin d'être rassurée.
Prête à suivre tous les traitements possibles si cela lui permet de guérir.
Tristesse de l'humeur en réaction à l'annonce de la semaine dernière, insomnies d'endormissement depuis.

Antécédents personnels :

Polyarthrite rhumatoïde non érosive (diagnostic en 2010)
Kystes ovariens.
Ménopausée depuis l'âge de 51 ans.
Pas d'ATCD chirurgical.

Antécédents familiaux :

Père : cancer de la prostate opéré, vers 62 ans.
Mère : problème de thyroïde sans précision ; diabète de type 2

Médicaments :

METHOTREXATE voie SC, tous les mercredis
SPECIAFOLDINE 5 mg

Allergie :

Urticaire au sparadrap.

Symptômes et signes physiques positifs :

“Gros ganglion” apparu dans le pli de l’aine à droite de manière isolée en été 2022.
Asthénie depuis environ 1 an.
Perte de 20 kg en 9 mois, avec perte d’appétit.
Splénomégalie à 2 travers de doigt.

Symptômes et signes physiques négatifs :

Absence de prurit.
Pas d’hépatomégalie.
Pas de difficulté à respirer, pas de douleur thoracique. Pas de troubles digestifs.

Mode d’apparition, ancienneté et évolution des symptômes :

Apparition et majoration progressive depuis l'été 2022.

Questions de relance :

Au bout de 5 min, si l’étudiant n’évoque pas les effets indésirables : “Est-ce que je vais avoir des effets secondaires des médicaments ?”
Au bout de 6 min, si l’étudiant n’évoque pas ses prescriptions : “Il n’y a rien à faire pour empêcher les effets indésirables ?”

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Étudiant assis en face du patient simulé.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Rappel de la consigne.